CŒUR · VAISSEAUX · CV-01

Coroscanner · CAD-RADS 2.0

CAD-RADS 2.0 (SCCT/ACC/ACR/NASCI 2022)
sténose, charge plaquaire, modificateurs

Principe : une catégorie par patient, fondée sur la **sténose la plus significative** (vaisseaux > 1,5 mm), complétée par la **charge plaquaire (P1–P4)** et des **modificateurs**. Format : **CAD-RADS [catégorie] / [modificateurs] / [P]**, ex. « CAD-RADS 3/HRP/P2 ».

CATÉGORIES DE STÉNOSE · DOULEUR THORACIQUE STABLE

CATÉGORIE	STÉNOSE MAXIMALE	INTERPRÉTATION	CONDUITE
0	0 %, ni plaque ni sténose	Absence de maladie coronaire	Pas d'autre exploration cardiaque
1	1–24 %, ou plaque sans sténose (y compris remodelage positif)	Maladie minime non obstructive	Pas d'autre exploration ; prévention selon la charge plaquaire
2	25–49 %	Maladie légère non obstructive	Pas d'autre exploration ; prévention
3	50–69 %	Sténose modérée	Envisager une évaluation fonctionnelle : FFR-CT, perfusion CT, échographie de stress, scintigraphie, TEP, IRM, FFR invasive
4A	70–99 % sur 1 ou 2 vaisseaux	Sténose sévère	Coronarographie ou évaluation fonctionnelle ; coronarographie favorisée si > 90 %, HRP, ischémie ou symptômes persistants
4B	**Tronc commun ≥ 50 %** ou atteinte **tritronculaire** ≥ 70 %	Sténose sévère	**Coronarographie recommandée**
5	100 % (occlusion totale)	Occlusion totale ou subtotale	Coronarographie, évaluation fonctionnelle ou de viabilité

Douleur thoracique aiguë : 0 SCA très improbable · 1 improbable · 2 peu probable · 3 possible · 4 probable · 5 très probable · N : SCA non exclu, autre exploration nécessaire. Intégrer troponine, ECG et HRP.

CHARGE PLAQUAIRE

CATÉGORIE	CHARGE	SCORE CALCIQUE (CAC)	SEGMENTS ATTEINTS (SIS)	ÉVALUATION VISUELLE
P1	Légère	1–100	≤ 2	1–2 vaisseaux, peu de plaque
P2	Modérée	101–300	3–4	1–2 vaisseaux, plaque modérée ; ou 3 vaisseaux, peu de plaque
P3	Sévère	301–999	5–7	3 vaisseaux, plaque modérée ; ou 1 vaisseau, plaque importante
P4	Étendue	> 1 000	≥ 8	2–3 vaisseaux, plaque importante

En cas de discordance, privilégier le score calcique ou la quantification de la plaque totale ; retenir l'évaluation la plus sévère.

MODIFICATEURS

N · S · G · E

- **N** : examen non diagnostique (catégorie = sténose minimale certaine)
- **S** : stent
- **G** : pontage
- **E** : exception (anomalie de naissance, fistule, dissection, anévrisme…)

HRP · plaque à haut risque

Au moins **2** des signes suivants :

- Plaque de **faible densité** (< 30 UH)
- **Remodelage positif** (≥ 10 % du diamètre de référence)
- **Calcifications ponctuées** (< 3 mm)
- **Signe de l'anneau** (« napkin-ring »)

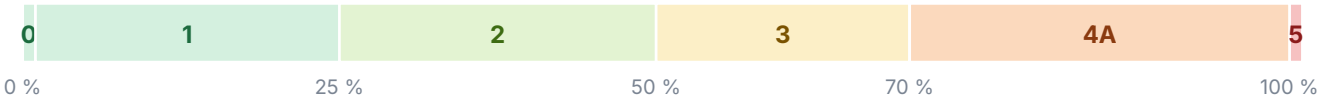
I · ischémie

- **I+** : ischémie en FFR-CT ou perfusion CT
- **I−** : pas d'ischémie
- **I±** : limite
- À indiquer seulement si réalisé

Coroscanner · CAD-RADS 2.0 (suite)

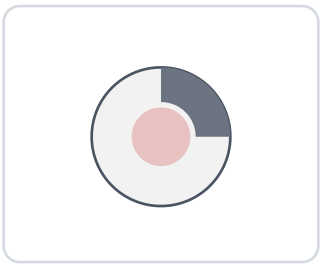
ATLAS VISUEL

Échelle de sténose et catégories

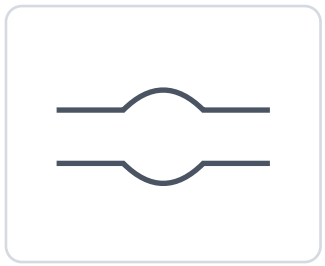


4B : tronc commun ≥ 50 % ou tritronculaire ≥ 70 % · 5 : occlusion totale

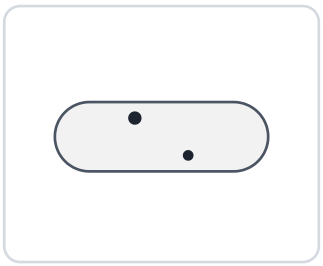
Plaque à haut risque (modificateur HRP) : au moins 2 signes



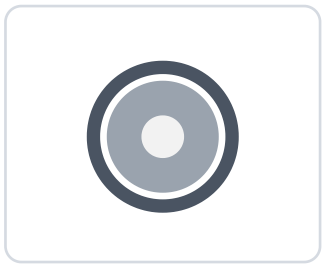
Faible densité
< 30 UH



Remodelage positif
≥ 10 % du diamètre



Calcifications ponctuées
< 3 mm



Signe de l'anneau
napkin-ring

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

CAD-RADS
Radiopaedia · catégories et modificateurs
radiopaedia.org/articles/coronary-artery-disease

Plaque vulnérable
Radiopaedia · signes de haut risque
radiopaedia.org/articles/vulnerable-plaque?lang=

Signe de l'anneau (napkin-ring)
Radiopaedia · définition
radiopaedia.org/articles/napkin-ring-sign-heart

Remodelage positif et anneau (cas)
Radiopaedia · coronaire droite
radiopaedia.org/cases/positive-remodeling-and-na

CAC-DRS (score calcique)
Radiopaedia · classes
radiopaedia.org/articles/coronary-artery-calcium

Sources : CAD-RADS 2.0 (JACC CV Imaging 2022) – www.jacc.org/doi/10.1016/j.jcmg.2022.07.002 · CAD-RADS 2.0 (Radiology: Cardiothoracic Imaging) – pubs.rsna.org/doi/10.1148/ryct.220183 · What is new in CAD-RADS 2.0 (HVT) – hvt-journal.com/articles/art351